

CAPÍTULO 14.3

Marcadores en Reumatología: Casos Clínicos

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

En la práctica reumatológica, existe una regla de oro que todo médico debe recordar para el examen EUNACOM y la práctica clínica: **La clínica siempre manda sobre el laboratorio**. Los autoanticuerpos y marcadores inflamatorios son herramientas de apoyo, pero nunca deben interpretarse de forma aislada, ya que pueden llevar a diagnósticos erróneos y ansiedad innecesaria en el paciente.

El dilema de los ANA positivos en pacientes asintomáticos

Es común encontrar pacientes sanos con títulos bajos de **Anticuerpos Antinucleares (ANA)**. La interpretación depende enteramente del contexto clínico.

- **Títulos bajos (1:40 o 1:60):** En una paciente asintomática, estos resultados suelen considerarse negativos o débilmente positivos sin significancia clínica. Hasta un 20-30% de la población sana puede presentar ANA positivos en títulos bajos.
- **Riesgo de sobre-estudio:** Solicitar ANA sin una sospecha clínica clara (como fenómeno de Raynaud, fotosensibilidad, artritis o sequedad ocular) es un error frecuente que genera incertidumbre terapéutica.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No solicite ANA como examen de "rutina" o "check-up". Si el paciente no tiene síntomas sugerentes de enfermedad del tejido conectivo, un resultado positivo solo generará ansiedad y derivaciones innecesarias.

Artritis Reumatoide (AR) con marcadores negativos

La **Artritis Reumatoide** es un diagnóstico fundamentalmente clínico. Aunque el **Factor Reumatoide (FR)** y los **Anti-CCP (Antipéptidos cíclicos citrulinados)** son de gran ayuda, su ausencia no descarta la enfermedad.

TABLA 14.3.1: CARACTERÍSTICA VS HALLAZGO CLÁSICO EN AR

CARACTERÍSTICA	HALLAZGO CLÁSICO EN AR
Distribución	Simétrica, afecta muñecas, metacarpofalángicas (MCF) e interfalángicas proximales (IFP).
Síntomas	Dolor articular y rigidez matinal de larga duración (>30-60 min).
Marcadores	FR y Anti-CCP (pueden ser negativos en la AR seronegativa).

Si una paciente presenta la clínica clásica (artritis de manos y rigidez matinal marcada), el diagnóstico sigue siendo **Artritis Reumatoide**, incluso si los marcadores específicos son negativos y los ANA resultan positivos (estos últimos pueden estar presentes en múltiples condiciones autoinmunes).

Fibromialgia: La trampa de los marcadores

La **Fibromialgia** se caracteriza por dolor crónico generalizado, pero **sin evidencia de inflamación articular (artritis)**.

- **Clínica:** Dolor a la palpación en puntos específicos (trapecios, supraespinosos, pectorales, cara interna de rodillas, glúteos).
- **Laboratorio:** Los exámenes de laboratorio (incluyendo ANA) suelen ser normales. Si un paciente con clara fibromialgia tiene ANA positivos, esto no cambia el diagnóstico; sigue siendo fibromialgia. Los marcadores no deben solicitarse si no hay sospecha de inflamación sistémica.

NOTA CLÍNICA

La diferencia clave entre artralgia y artritis es que la **artritis** presenta signos inflamatorios objetivos al examen físico (aumento de volumen, calor, limitación del rango articular), mientras que la artralgia es solo el síntoma de dolor.

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Clínica vs. Especificidad

El **Lupus Eritematoso Sistémico** es la enfermedad autoinmune sistémica por excelencia. Su diagnóstico se basa en criterios clínicos y de laboratorio (SLICC o EULAR/ACR).

Caso de Superposición (Overlap)

Un paciente puede tener clínica de Lupus (fotosensibilidad, úlceras, serositis) pero presentar anticuerpos **Anti-RNP** positivos (característicos de la **Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo**) y Anti-DNA negativo. - En estos casos, se debe evaluar si el paciente cumple criterios para ambas patologías, lo que se denomina **Síndrome de Solapamiento** o sobreposición.

El valor del Anti-DNA de doble hebra (dsDNA)

En un paciente con eritema malar, orina espumosa (sugerente de **Nefropatía Lúpica**), alopecia, úlceras orales y citopenias (linfopenia y plaquetopenia), el diagnóstico de LES es indiscutible.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El **Anti-DNA de 2 hebras** es altamente específico para LES y se relaciona con la actividad de la enfermedad (especialmente el compromiso renal), pero su **sensibilidad es baja** (solo está positivo en aproximadamente el 50% de los pacientes). Un Anti-DNA negativo NO descarta Lupus.

Espondiloartropatías: La importancia de ser "Seronegativo"

Las espondiloartropatías, como la **Espondilitis Anquilosante**, se definen clásicamente por la ausencia de marcadores reumatológicos tradicionales.

- **Clínica clásica:** Hombre joven con **dolor lumbar de características inflamatorias** (aumenta con el reposo, máximo en la mañana, mejora con el ejercicio).
- **Perfil de laboratorio:**
 - Factor Reumatoide: Negativo.
 - ANA: Negativos.
 - Anti-CCP: Negativos.
 - ANCA: Negativos.

Este perfil "seronegativo" refuerza el diagnóstico de una espondiloartropatía en lugar de excluirla. El marcador genético asociado (aunque no diagnóstico por sí solo) es el **HLA-B27**.

EUNACOM CRITERIOS

El lumbago inflamatorio se diferencia del mecánico porque: 1. Comienza en personas jóvenes (<45 años). 2. Es de inicio insidioso. 3. Mejora con el movimiento y no con el reposo. 4. Produce dolor nocturno.

Resumen de Marcadores y su utilidad

TABLA 14.3.2: MARCADOR VS ENFERMEDAD ASOCIADA		
MARCADOR	ENFERMEDAD ASOCIADA	PERLA EUNACOM
ANA	Lupus (LES), Esclerodermia	Muy sensible para LES, pero poco específico.
Anti-dsDNA	Lupus (LES)	Muy específico, marcador de actividad renal.
Anti-Sm	Lupus (LES)	El más específico para LES (aunque poco sensible).
Anti-Ro / Anti-La	Síndrome de Sjögren / Lupus neonatal	Riesgo de bloqueo cardíaco congénito en embarazo.
Anti-RNP	Enf. Mixta del Tejido Conectivo	Presente en síndromes de sobreposición.
Anti-CCP	Artritis Reumatoide	Más específico que el Factor Reumatoide; marcador de erosión.
ANCA-C (PR3)	Granulomatosis con Poliangéitis (Wegener)	Útil en vasculitis de vaso pequeño.
ANCA-P (MPO)	Poliangéitis Microscópica / Churg-Strauss	Útil en vasculitis de vaso pequeño.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca inicie tratamiento inmunosupresor potente basándose únicamente en un examen de laboratorio positivo si el paciente no presenta una clínica concordante.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 35 años, asintomática, con ANA positivos en dilución 1:40 en exámenes de rutina. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Marcadores en Reumatología: Casos Clínicos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los marcadores reumatológicos pueden ser una trampa: siempre manda la clínica por sobre los marcadores
- No se debe pedir ANA a personas asintomáticas, ya que un 5% de sanos pueden tenerlos positivos
- Una artritis reumatoide puede tener factor reumatoide y anti-CCP negativos y seguir siendo AR si la clínica es compatible
- El dolor muscular generalizado con examen articular normal y fuerzas normales orienta a fibromialgia, no a enfermedad del tejido conectivo
- El anti-DNA doble hebra solo está positivo en ~50% de los lupus: su negatividad no descarta el diagnóstico
- Las pelvispondiloartropatías como la espondilitis anquilosante son seronegativas: todos los anticuerpos negativos es consistente con el diagnóstico
- Los ANA positivos con cuadro de fibromialgia no cambian el diagnóstico a enfermedad del tejido conectivo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MARCADORES EN REUMATOLOGÍA: CASOS CLÍNICOS)

PREGUNTA 1

Mujer de 35 años, asintomática, con ANA positivos en dilución 1:40 en exámenes de rutina. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- ☐ A) Iniciar hidroxicloroquina como profilaxis de lupus
- ☐ B) Solicitar perfil ENA completo y biopsia renal
- ☐ C) Explicar que es un hallazgo inespecífico, observar si aparecen síntomas reumatológicos
- ☐ D) Derivar inmediatamente a reumatología para inicio de tratamiento
- ☐ E) Solicitar ANCA y factor reumatoide

PREGUNTA 2

Mujer de 45 años con poliartritis de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas, rigidez matinal de 2 horas. Factor reumatoide negativo, anti-CCP negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Artrosis de manos
- ☐ B) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ C) Artritis reumatoide
- ☐ D) Fibromialgia
- ☐ E) Enfermedad mixta del tejido conectivo

PREGUNTA 3

Mujer de 22 años con eritema malar, úlceras orales, linfopenia, plaquetopenia y ANA positivos, pero anti-DNA doble hebra negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Enfermedad mixta del tejido conectivo
- ☐ B) Lupus eritematoso sistémico
- ☐ C) Síndrome antifosfolípido primario
- ☐ D) Dermatomiositis
- ☐ E) Fibromialgia

RESUMEN: MARCADORES EN REUMATOLOGÍA: CASOS CLÍNICOS

Esta clase presenta casos clínicos que demuestran que en reumatología siempre gana la clínica por sobre los marcadores. Los marcadores pueden ser una trampa y no deben guiar el diagnóstico cuando el cuadro clínico es claro. Se presentan seis casos: una mujer sana con ANA positivos en dilución baja (sana, no debieron pedirse ANA); una mujer con clínica de artritis reumatoide pero factor reumatoide y anti-CCP negativos (sigue siendo AR porque manda la clínica); una mujer con dolor muscular generalizado y ANA positivos (fibromialgia, no una ETC); una mujer con clínica de lupus y anti-RNP positivo (evaluar si calza más con lupus o enfermedad mixta); una mujer con múltiples criterios de lupus pero anti-DNA doble hebra negativo (sigue siendo LES, el anti-dsDNA solo está positivo en ~50% de los casos). El último caso es un hombre joven con lumbago inflamatorio y todos los marcadores negativos, lo cual es consistente con una espondilitis anquilosante (pelvispondiloartropatía seronegativa). La conclusión es que ninguno de los cuadros calzaba con los anticuerpos, pero la clínica siempre permite hacer el diagnóstico correcto.